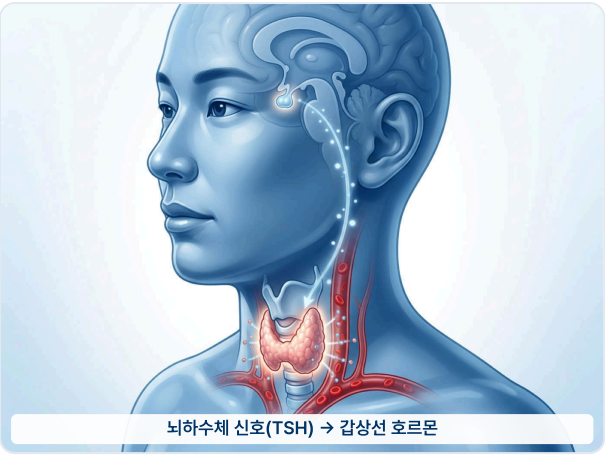
갑상선 기능검사 결과 안내

갑상선 검사는 TSH(갑상선자극호르몬)와 Free T4(유리 갑상선호르몬)를 중심으로 해석합니다. 수치가 조금 벗어나도 일시 변화, 약·영양제, 임신, 갑상선염 등에 따라 달라질 수 있어 증상과 재검을 함께 봅니다.

주요 항목 이해하기



뇌하수체 신호(TSH) → 갑상선 호르몬

항목	무엇을 보나	풀이
TSH	조절	뇌하수체 신호
Free T4	호르몬	활성 전 단계
T3	항진	평가에 도움
항체	원인	자가면역 확인

대표적인 결과 패턴

패턴	기능저하 쪽 패턴	기능항진 쪽 패턴
TSH·호르몬	**TSH 높고 Free T4 낮음** — 갑상선기능저하증 가능	**TSH 낮고 Free T4/T3 높음** — 갑상선기능항진증 가능
TSH만 이상	**TSH만 약간 높음** — 무증상 갑상선기능저하, 재검 필요	**TSH만 낮음** — 초기 항진, 약물 영향, 일시 변화 확인
증상	**피로·추위·변비·부종** — 증상과 함께 해석	**두근거림·체중감소·손떨림** — 빠른 평가 필요
항체	**TPO 항체(갑상선 과산화효소 항체) 양성** — 하시모토 갑상선염 가능	**TRAb(갑상선자극호르몬 수용체 항체) 양성** — 그레이브스병 가능
함께 보기	기능저하로 갑상선호르몬제(레보티록신)를 시작하면 복용법 안내 edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/thyroid-hormone-taking/ · 진료실 설명 edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/hypothyroidism/	기능항진증·그레이브스병 진료실 설명 edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/hyperthyroidism-graves/

검사 전후 주의할 점

결과를 흔들 수 있음

비오틴 — 고용량 복용 시 TSH/T4 결과 간섭 가능

임신·출산 후 — 정상 범위와 해석이 달라질 수 있음

감기·중증 질환 후 — 일시적 변화 가능

갑상선약 복용 시간 — 검사 날은 약 먹기 전에 채혈합니다(이미 드셨다면 알려 주세요)

다음 단계

재검 — 경미한 이상은 보통 6~12주 후 확인

항체 검사 — 원인 감별에 도움

초음파 — 결절·갑상선염 의심 시 시행

약물 조정 — 임의 시작·중단 없이 진료 후 결정

빨리 진료가 필요한 신호

안정 시 심한 두근거림, 흉통, 숨참, 고열, 심한 손떨림, 갑작스러운 체중 감소가 있으면 갑상선기능항진 평가가 필요합니다. 심한 무기력, 저체온감, 부종, 서맥이 뚜렷한 경우도 진료를 미루지 마세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — American Thyroid Association · NIDDK thyroid tests · 대한갑상선학회 자료

본 자료는 공통 설명용입니다. 실제 진단과 치료는 증상, 복용약, 임신 여부, 재검 결과를 함께 보고 결정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/thyroid-function/